Niveles asistenciales y lugares de atención

Cuando hablamos de niveles asistenciales, hablamos de diferentes modalidades de atención sanitaria que nos permiten una adecuada atención integral del paciente, multi e interdisciplinar y en base a las necesidades del paciente.

Los niveles asistenciales van vinculados a la complejidad de las enfermedades que tengamos delante y responden básicamente a dos niveles:

- **El básico (media complejidad):** con equipo de atención que no conllevan una especialización amplia y para aquellos procesos de la enfermedad y/o estadios de la enfermedad de complejidad media que no requieran técnicas complejas y/o utilización de herramientas específicas que solo deban ser utilizadas por profesionales altamente especializados en la patología concreta. El equipo de atención está compuesto por Médico internista/geriatra, médico general, enfermera y trabajador social. El médico general puede ser responsable de la atención con el apoyo del médico internista/geriatra.

- **El especializado (alta complejidad):** con equipo de atención y soporte altamente especializados y para aquellos procesos y/o estadios de la enfermedad que requieran técnicas y tratamientos más complejos que deban ser suministrados y/o seguidos por equipos de atención altamente especializados en la patología en cuestión y/o conlleven la necesaria utilización de herramientas que solo deban ser utilizadas por profesionales altamente especializados. El equipo de atención está compuesto por Médico internista/geriatra (responsable de la atención), médico general (apoyo), enfermera y trabajador social, junto a la disponibilidad de subespecialistas (Cardiólogo, Nefrólogo, Neumólogo, Gastroenterólogo o Hepatólogo) para apoyo e interconsultas.

Cada uno de los niveles de atención se puede llevar a cabo en diferentes lugares, delimitando principalmente tres:

- **Domiciliario:** donde en principio podremos atender a aquellas personas con un grado de complejidad de su patología medio (en algunas ocasiones con un grado medio-alto de complejidad o incluso alto) que no tenga capacidad para desplazarse hasta las consultas de especializada de su enfermedad y deban ser atendidos en casa, bien por un equipo de atención básico si su complejidad no es alta o bien por un equipo especializado si su complejidad es mayor e incluso por un equipo altamente especializado de recursos tales como la hospitalización domiciliaria.

- **Ambulatorio:** para aquellos pacientes que con un grado de complejidad en su patología media o media-alta que pueden desplazarse hasta las consultas de especializada para el seguimiento y control de su enfermedad(equipo de atención básico + soporte especializado/especialistas).

- **Hospitalario:** para aquellos pacientes que su nivel de complejidad en su patología más elevado o complicaciones les exija unas pruebas y procesos que no puedan prestarse en otros lugares de atención. Es decir, donde las necesidades tecnológicas no sean factibles desde otros recursos mayormente vinculados a la atención en domicilio o a la atención en ambulatorio (consultas externas) o que la atención que precisa el paciente no se puede llevar a cabo en otro lugar de atención que no sea el hospitalario por restricciones legales, por ejemplo. Los pacientes que son atendidos en el hospital tienen una complejidad alta en el momento de la atención debido principalmente a descompensaciones de la enfermedad o a estadios muy avanzados de la enfermedad que impliquen procesos hospitalarios.

En algunas ocasiones podríamos hablar de un cuarto lugar de atención que sería el **Centro Sociosanitario**, en el que tendremos una simbiosis entre el nivel básico y el especializado, ya que en él se contaría con personal social y sanitario específico y en algunos de estos centros se podría realizar un abordaje de la complejidad en todos sus grados. A veces para el recurso que presta la actividad este centro Sociosanitario puede asimilarse al domicilio.

Por tanto, el nivel asistencial va vinculado a la complejidad del paciente (según su patología), pero no al lugar de atención de este.

En el Manual debe quedar reflejado el nivel de asistencial que puede atender el recurso, la complejidad de los pacientes a atender y el lugar donde va a prestar la asistencia.

- Nivel Básico se puede proporcionar mediante:
    - Atención domiciliaria básica: con un equipo de profesionales básico, para pacientes sin posibilidad de desplazamiento.
    - Atención ambulatoria básica: con un equipo de profesionales básico, para pacientes con posibilidad de desplazamiento.
    - Atención Sociosanitario: para pacientes institucionalizados con o sin posibilidad de desplazamiento y para pacientes que por motivos sociales principalmente no pueden de forma momentánea o permanente permanecer en sus hogares, con equipos básicos de atención que se refuerzan con prestadores externos si es necesario.
- Nivel Especializado de atención se puede proporcionar mediante:
    - Atención domiciliaria o ambulatoria: con un equipo especializado de soporte al nivel básico para intervenciones en domicilio de mayor complejidad.

- Atención específica para las patologías concretas, a través de hospital de día y/o mediante ingreso.

- Atención hospitalaria: bien con hospitalización a domicilio, bien con ingreso en Unidades de crónicos o unidades específicas.

- Atención en Centro sociosanitario: con equipo especializado de soporte y permanencia en sus instalaciones.